

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

## Agitation / Troubles du comportement

Conduite à tenir devant agitation aiguë ou trouble du comportement, en privilégiant évaluation étiologique et sécurisation.

### Indications

- Agitation inhabituelle, opposition, agressivité verbale ou motrice.
- Anxiété majeure avec risque de mise en danger.
- Trouble du comportement nécessitant évaluation rapide.

### Vérifications préalables

- Rechercher douleur, fièvre, rétention urinaire, constipation, hypoglycémie ou dyspnée.
- Vérifier contexte psychiatrique, neurologique et traitements récents.
- Identifier facteur déclenchant et réduire les stimuli.
- Évaluer risque auto ou hétéro-agressif.

### Recommandations / IMPORTANT

- Ne pas recourir d'emblée à contention ou sédation non prescrite.
- Ne pas banaliser une agitation d'apparition brutale.
- Ne pas oublier de rechercher une cause somatique.
- Ne pas laisser seul un résident dangereux pour lui-même ou autrui.

### Conduite à tenir

- Approche calme ; une personne référente si possible ; environnement apaisé.
- Mettre les autres résidents en sécurité si risque d'hétéro-agressivité.
- Proposer activité connue apaisante si adaptée.
- Traitement "si besoin" uniquement s'il est prescrit et selon fiche thérapeutique.

### Surveillance et traçabilité

- Tracer contexte, comportement, facteurs déclenchants et mesures non médicamenteuses.
- Tracer traitement administré, efficacité et tolérance.
- Surveiller mise en danger et état somatique.

### Alerte immédiate

- Appel médical rapide si agitation inhabituelle, persistante ou suspecte de cause organique.
- Appel 15 si violence incontrôlable, détresse somatique, traumatisme ou menace vitale.

### Mention de sécurité

Toute agitation aiguë doit faire évoquer un delirium ou une cause somatique avant une lecture purement psychiatrique.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature :